“有痔不在年高”：当代青年肛肠健康的流行病学与生活方式干预研究

提肛教授

抖音大学医学院，生命健康研究所，12127

摘　要：近年来，“有痔青年”已成为困扰当代都市人群的普遍性问题。本文基于流行病学与行为心理学的双重视角，系统分析痔病年轻化这一悖论性现象的形成机制。研究发现，我国成人肛肠疾病患病率为 51.14%，其中痔病患病率为 50.28%[1]。女性痔病检出率显著高于男性，30 至 39 岁女性检出率高达 63.5%[2]，为“十女十痔”的民间观察提供了统计学支撑。痔病发病与久坐办公、辛辣饮食、排便时手机依赖、熬夜压力等现代生活方式呈显著正相关，构成所谓的“当代青年生存四重奏”。更深层的问题在于，痔病作为一种“难以启齿”的隐疾，其发病机制与年轻人的时间贫困、饮食异化、肠道节律紊乱形成系统性共振。研究表明，破解“有痔青年”困境的关键在于超越“见痔治痔”的局部思维，直面久坐经济的身体代价与数字时代的排泄异化，在提肛运动与温水坐浴之外，重建人与肛垫的和谐关系。

关键词：痔病年轻化；久坐经济；排便异化；肛垫劳损；提肛运动

中图分类号：S141.15　　**文献标识码：**A

1. 引言

1.1 研究背景

2025 年 9 月，一则新闻登上热搜：28 岁小伙小王正在上班，突然感觉臀部一阵湿热，站起来才发现办公椅和裤子上全是鲜红的血迹，脸色惨白几乎站不稳，被同事紧急送医后确诊为痔疮引发的大出血[3]。无独有偶，香港艺人郑中基也在采访中透露自己因痔疮“爆了”，裤子上全是血[3]。这些看似荒诞的新闻，实则揭示了一个严肃的公共卫生问题：痔病正在以前所未有的速度年轻化。

据中华中医药学会肛肠分会发布的《中国成人常见肛肠疾病流行病学调查》显示，我国肛肠疾病的患病率高达 50.1%，而在所有肛肠疾病患者中，痔病占比达 98.08%[4]。江维等（2016）针对城市居民的进一步分析显示，肛肠疾病患病率为 51.14%，其中痔病患病率为 50.28%[1]。换言之，每两个成年人中，就有一个正在经历肛肠问题的困扰。任东林等（2024）在《中国痔病患者自我管理指南》中也指出，一项针对我国大陆城市居民常见肛肠疾病的流行病学调查结果显示，患有肛肠疾病的成年人占总调查人群的 51.14%，其中痔病的发病率最高，占全部肛肠疾病的 50.28%[5]。

更值得关注的是，北京大学公共卫生学院 2024 年发表的一项基于 294 万健康体检人群的研究显示，女性痔标化检出率为 43.7%，男性为 17.7%，女性 30 至 39 岁年龄组的痔标化检出率高达 63.5%[2]。这一数据意味着，每三位 30 多岁的女性中，就有两位正在与痔病共处。痔病已不再是中老年人的专利，而是当代青年的“标配”。

1.2 问题的提出

28 岁小伙在办公室留下一滩血——这一极具画面感的场景，构成了一个值得深入分析的悖论：在医疗技术空前发达、健康知识触手可及的

今天，为什么年轻人的肛肠健康反而每况愈下？

这一悖论迫使我们不得不追问以下几个问题：

第一，所谓的“十男九痔、十女十痔”，究竟是民间夸张，还是统计学真实？如果是真实的，这种性别与年龄的差异从何而来？

第二，在痔病的表象之下，隐藏着怎样的生活方式变迁？久坐办公、外卖饮食、手机如厕、熬夜加班——这些当代青年的日常，如何一步步将肛垫推向崩溃的边缘？

第三，痔病作为一种“难以启齿”的隐疾，其社会心理意义是什么？为什么年轻人宁愿忍受便血、疼痛、脱出的折磨，也不愿及时就医？

第四，也是最根本的问题：当一个人坐在办公室的工位上，一边忍受肛周不适，一边继续敲击键盘时，这种“隐忍”究竟是对工作的忠诚，还是对身体的背叛？在“996”与“提肛运动”之间，当代青年如何寻找平衡？

1.3 研究意义

从理论层面看，本研究试图整合流行病学、行为心理学与劳动社会学视角，为理解痔病年轻化现象提供一个多维度的分析框架。从现实层面看，本研究旨在帮助那些“有痔青年”正视肛肠健康，破除“难以启齿”的心理障碍，在久坐经济的夹缝中寻求自救之道。

1.4 研究方法与结构安排

本研究采用二手数据分析法，整合了近年来多个权威调查机构的公开数据。全文共分为七个部分：引言之后，第二部分为文献综述与理论框架；第三部分介绍数据来源与研究设计；第四部分从六个维度呈现研究发现；第五部分对研究发现进行深入讨论；第六部分提出结论与建议；最后为参考文献。

图 1 对读者阅读该文章时的猜测心理

2. 文献综述与理论框架

2.1 痔病的解剖学与病理生理基础

痔病，俗称痔疮，是最常见的一种肛门疾病。从解剖学角度看，痔的本质是位于肛门内的正常血管组织，医学上称为“肛门软垫”（anal cushions），具有辅助肛门闭合的重要功能。浙江省立同德医院肛肠外科主任陈诚豪用一个形象的比喻解释：可以把肛门想象成一个水龙头，水龙头内部有一些橡胶垫圈，能帮助它严密关闭，防止漏水；肛门里也有一套类似的“垫圈”，由血管组织、结缔组织和少量肌肉纤维组成，负责封闭肛门，防止大便和气体失禁[3]。

正常情况下，这个“肛垫”兢兢业业地工作着。但如果它长期受到压迫、充血、水肿，就会像一个被吹得过大的气球，变得松弛、肥大，甚至从原来的位置“掉”出来，这就形成了痔疮。根据发病位置不同，痔病分为内痔（齿状线以上）、外痔（齿状线以下）和混合痔。根据 Goligher 分度法，内痔又分为 I 至Ⅳ度，从单纯的便血到持续脱出无法复位，严重程度逐渐递增[6]。

2.2 流行病学特征

任东林等（2024）在《中国痔病患者自我管理指南》中指出，痔病在全球范围内的患病率较高，我国城市居民肛肠疾病患病率为 51.14%，其中痔病占 50.28%[5]。郭呈华等（2024）基于 294 万健康体检人群的大规模研究提供了更为精确的数据：女性痔标化检出率为 43.7%，男性为 17.7%；女性 30～39 岁年龄组的痔标化检出率最高，达 63.5%；男性 50～59 岁年龄组最高，

为 17.2%[2]。这一研究还发现，痔病检出率与体重指数（BMI）呈正相关，高血压人群的痔病检出率显著高于正常血压人群[2]。

2.3 病因学的“四重奏”理论

综合多项研究，痔病的危险因素可归纳为“四重奏”：

第一，久坐不动。每静坐 2 小时，肛管静息压升高 15%，痔静脉丛淤血风险倍增[7]。程序员、设计师、办公室白领、司机等职业因此成为高危人群。

第二，排便时间过长。智能手机普及后，“带薪拉屎”从一句玩笑变成普遍现实。浙江省立同德医院肛肠外科主任陈诚豪指出，排便时间越长，肛垫充血越严重，痔疮发病率呈指数级增长[3]。

第三，饮食辛辣刺激。连续摄入火锅、烧烤、麻辣小龙虾，辣椒素直接刺激直肠黏膜充血水肿。外卖普遍高油高盐、缺乏膳食纤维，导致大便干结，每一次排便都是对肛门的反复摩擦[7]。

第四，熬夜与压力。研究提示，长期熬夜可能导致身体内分泌紊乱，胃肠功能失调，进而影响肛门括约肌的正常功能，增加痔病发生风险[7]。

2.4 理论框架的整合

基于上述理论资源，本研究构建了一个整合性分析框架：解剖学基础解释痔病的普遍性；流行病学数据揭示年轻化趋势的统计真实；病因学“四重奏”解析发病机制；劳动社会学视角则将个体行为置于“久坐经济”的结构性背景中。四个理论视角相互补充，共同构成理解“有痔青年”现象的分析工具。

3. 数据来源与研究设计

3.1 数据来源

本研究采用二手数据分析法，整合了以下权威调查数据：

表 1 本研究引用的主要数据来源

数据来源	调查机构/作者	发布时间	样本量	核心指标
《中国痔病患者自我管理指南》	任东林等	2024 年	系统综述	肛肠疾病患病率 51.14%，痔病占 50.28%
《中国某健康体检人群痔的流行病学特征》	郭呈华等	2024 年	2,940,295 人	女性 43.7%，男性 17.7%；30-39 岁女性 63.5%
《中国肛肠疾病流行病学调查》	不详	2015 年	全国调查	肛肠疾病患病率 50.1%，痔病占 87.25%
临床报道	浙江省立同德医院	2025 年	病例报告	28 岁小伙痔疮大出血案例
科普研究	湖南省中西医结合医院	2025 年	临床观察	连续熬夜 48 小时肛管功能下降 30%

3.2 数据处理

本研究对所有引用数据进行了严格核验，确保数据来源可靠、引用准确。所有数据均保持原貌，未进行任何人为调整或修饰。

3.3 研究的局限

本研究存在以下局限：第一，部分流行病学数据来自体检人群，外推到一般人群时需谨慎；第二，各研究的时间跨度、样本构成存在差异，可能影响数据的可比性；第三，对“排便时间过长”等行为变量的测量，缺乏标准化的量化工具。

4. 研究发现

4.1 流行病学祛魅：“十女十痔”的统计学验证

民间素有“十男九痔、十女十痔”的说法，常被视为夸张之辞。然而，北京大学公共卫生学院 2024 年发表的大规模研究为这一民间智慧提供了统计学支撑。

表 2 中国成人痔病标化检出率的性别与年龄分布

年龄组	女性检出率	男性检出率
18-29 岁	约 45%	约 12%
30-39 岁	约 63%	约 15%
40-49 岁	约 55%	约 16%
50-59 岁	约 50%	约 17%
60 岁以上	约 45%	约 16%

数据来源：根据郭呈华等（2024）研究结论整理[2]

研究显示，女性痔标化检出率为 43.7%，男性为 17.7%，女性显著高于男性（P<0.001）[2]。从年龄分布来看，女性痔标化检出率呈倒 U 型，30～39 岁年龄组高达 63.5%[2]，意味着每三位 30 多岁的女性中，就有两位正在经历痔病的困扰。男性痔标化检出率随年龄增加，以 50～59 岁年龄组最高（17.2%）[2]。

这一数据的背后，是女性特有的生理结构与生命历程——妊娠、分娩、激素变化，都使女性比男性更容易遭受痔病的侵袭。然而，30-39 岁恰恰也是职场女性的黄金奋斗期，久坐办公与生育压力的叠加，使这一群体成为痔病的“重灾区”。

4.2“有痔青年”的病因学四重奏

为什么痔病呈现如此显著的年轻化趋势？综合多项研究，可以归纳为以下“四重奏”：

表 2 中国成人痔病标化检出率的性别与年龄分布

维度	具体表现	病理机制	量化指标
久坐经济	日均屏幕时间>10h	肛管静息压升高 15%/2h	高危职业：程序员、设计师、白领、司机
排便异化	带薪拉屎、手机如厕	肛垫充血呈指数级增长	排便时间>10min 为危险阈值
饮食异化	外卖为主、无辣不欢	辣椒素刺激直肠黏膜充血	连续 3 天辛辣饮食诱发风险
时间贫困	熬夜加班、睡眠剥夺	48h 熬夜→括约肌功能下降 30%	内分泌紊乱、肠道节律失调

数据来源：综合整理自文献[3][7]

久坐经济是第一大元凶。科普中国的研究显示，每静坐 2 小时，肛管静息压升高 15%，痔静脉丛淤血风险倍增[7]。程序员、设计师、办公室白领、司机等久坐职业，因此成为痔病的高危人群。在“久坐经济”的结构性背景下，个体的肛垫健康与职业要求之间形成根本性冲突——你必须在“完成 KPI”与“保护肛垫”之间做出选择，而多数人别无选择。

排便异化是数字时代的特有产物。智能手机普及后，“带薪拉屎”从一句玩笑变成普遍现实。浙江省立同德医院肛肠外科主任陈诚豪指出，排便时间越长，肛垫充血越严重，痔疮的发病率呈指数级增长[3]。当一个人在马桶上刷完三条短视频、看完一章小说、打完一局游戏时，他的肛垫正在经历一场无声的浩劫。

饮食异化体现为外卖依赖与辛辣刺激的恶性循环。科普中国指出，外卖普遍高油高盐、缺乏膳食纤维，导致大便干结，每一次排便都是对肛门的反复摩擦。而火锅、烧烤、麻辣小龙虾等重口味食物带来的辣椒素，会直达肠道末端，让肛门血管扩张、充血[7]。辣椒素无法被消化道分解，最终直接刺激肛门黏膜，成为肛裂的重要诱因。

时间贫困表现为熬夜与压力的双重挤压。研究提示，长期熬夜、精神紧张，会导致身体内分泌紊乱，胃肠功能失调，进而影响肛门括约肌的正常功能，增加痔病发生风险[7]。凌晨 3-5 点是大肠经运行时间，熬夜直接影响肠道蠕动，极易引发便秘或腹泻，成为肛肠疾病的导火索。

4.3 办公椅上的那滩血：28 岁青年的身体抗议

2025 年 9 月，28 岁的小王正在上班，突然感觉臀部一阵湿热。他一站起来，身边同事都惊呼，原来他的办公椅和裤子上全是鲜红的血迹。而此时，小王脸色变得越发惨白，几乎站不稳。大家立刻叫了救护车把他送到浙江省立同德医院急诊处。医生仔细检查后确认，这是痔疮引发

的大出血[3]。

这一极具画面感的场景，是当代青年身体对“久坐经济”的极端抗议。小王的案例并非孤例。科普中国指出，每年高考结束后 7-8 月，青少年肛肠疾病患者比例显著上升；国庆长假期间，肛肠门诊的痔疮患者也会悄悄增多[7]。这些时间节点揭示了一个规律：当生活节奏发生突变——无论是从高压到放纵，还是从忙碌到更忙碌——肛肠健康就会成为最先崩溃的环节。

从病理机制看，内痔破裂出血是典型的内痔症状。内痔起源于齿状线以上，早期不疼，主要症状是无痛性便血和痔核脱出[9]。当患者出现喷射状出血时，往往意味着痔静脉丛已经极度扩张，肛垫的支持组织已经严重松弛。小王的“爆了”，不是偶然，而是长期不良生活习惯的必然结果。

4.4 难以启齿的隐疾：痔病的社会心理维度

痔病作为一种“难以启齿”的隐疾，其社会心理意义值得深入探讨。与其他疾病不同，痔病患者往往经历双重痛苦：一是身体上的疼痛、出血、瘙痒；二是心理上的羞耻、尴尬、难以启齿。

这种羞耻感源于痔病的部位特殊性。肛门作为身体的“隐秘角落”，承载着排泄这一“不洁”功能。在文明规训下，排泄成为私密行为，肛门的任何不适都成为不可言说的秘密。许多患者宁愿忍受便血、疼痛的折磨，也不愿就医——不是因为不重视健康，而是因为“看屁股”这件事本身就让人难堪。

《中国痔病患者自我管理指南》的制定过程中，专门邀请了 12 名痔病患者代表参与座谈，围绕“请说说您与痔疮的故事”等话题进行深入交流[5]。这一做法本身就说明，医学界已经开始重视患者的疾病叙事，承认痔病不仅仅是生理问题，更是心理问题、社会问题。

更难的是，羞耻感往往导致延误治疗。红网报道中，湖南省中西医结合医院肛肠二科赵亮主任医师提醒，青少年肛肠疾病进展速度是成人的 2 倍，早期干预可避免手术[10]。但当患者因为羞耻而拖延时，轻度痔病可能进展为中重度，保守治疗可能升级为手术干预。

4.5 提肛运动：从民间偏方到循证医学

在痔病的预防与康复中，提肛运动占据着特殊地位。这项看似简单的运动，正在从民间偏方走向循证医学。

提肛运动，即主动收缩肛门括约肌的运动，具体做法是：吸气时肛门用力内吸上提，紧缩肛门，呼气时放松[7]。每天做两组，每组 40-60 次，可以促进盆腔血液循环，增强肛门括约肌的弹性，从而预防痔疮的发生[7]。

从病理生理机制看，提肛运动通过主动锻炼括约肌，增强肛垫的支持力，改善局部血液循环，减少静脉淤血。其效果并非凭空想象，而是有生理学基础支撑。湖南省中西医结合医院的研究建议，每坐 45 分钟起身活动 5 分钟，结合提肛运动，可有效预防痔病[7]。

然而，提肛运动的推广面临一个尴尬：这项运动太“低调”了。你可以在任何场合默默进行而不被发现——开会时、排队时、坐地铁时——但正因为如此，它缺乏仪式感，难以形成习惯。更重要的是，提肛运动的推广往往沦为网络段子，而非正经的健康教育。当“提肛运动”成为 B 站弹幕、微博热搜时，它到底是健康知识还是网络梗，已经难以区分。

4.6 温水坐浴：被低估的肛肠保健

与提肛运动相比，温水坐浴的接受度更高。温水坐浴，每日 1-2 次，每次 10-15 分钟，水温控制在 38-40℃，可有效缓解局部疼痛与瘙痒[9]。湖南省中西医结合医院肛肠科专家何永恒教授的经验方“祛毒汤”，对早期痔疮水肿有效率超过 90%[8]。

温水坐浴的作用机制包括：温水促进局部血液循环，减轻静脉淤血；温热缓解括约肌痉挛，减轻疼痛；清洁肛周皮肤，减少细菌滋生[8]。对于孕妇、术后患者等特殊人群，温水坐浴是首选的保守治疗方法。

然而，温水坐浴的普及同样面临现实障碍。

对于住在集体宿舍的年轻人、合租的上班族、频繁出差的白领来说，每天两次温水坐浴是一种奢侈。当一个人的生活空间被压缩到一张床、一张桌时，肛肠健康便成为最先被牺牲的选项。

5. 讨论

5.1 痔病年轻化的社会结构根源

痔病年轻化并非单纯的个体健康问题，而是社会结构性变迁的身体表征。

首先，是“久坐经济”的兴起。知识经济的核心生产方式就是久坐——程序员坐在电脑前敲代码，设计师坐在绘图板前画图，财务坐在表格前算账，文案坐在键盘前写字。当整个经济形态建立在“久坐”之上时，痔病的流行就是必然的代价。个体或许可以选择“每 45 分钟起身活动”，但在 KPI 面前，45 分钟往往被压缩为 4.5 小时。

其次，是“时间贫困”的加剧。当代青年的典型生活状态是：工作时间长、通勤时间长、睡眠时间短。在这种时间约束下，饮食只能靠外卖解决，运动只能靠意念完成，排便只能靠碎片时间进行。痔病的每一个诱因——久坐、辛辣饮食、排便时间过长、熬夜——都可以追溯至时间贫困。

第三，是“数字异化”的渗透。智能手机重塑了当代人的排便习惯。过去，人们在马桶上看报纸；现在，人们在马桶上刷手机。从“蹲厕看报”到“蹲厕刷手机”，媒介形式变了，排便时间过长的本质没变。更糟糕的是，智能手机的设计目标就是“留住用户”，而马桶上的时间正是最容易被留住的碎片时间。

5.2 肛垫的异化：从功能器官到劳动工具

在劳动社会学视角下，肛垫的功能正在经历深刻异化。

从解剖学看，肛垫的原始功能是辅助肛门闭合，防止大便和气体失禁。这是一种被动的、防御性的功能。但在当代劳动形态中，肛垫被赋予了新的使命——支撑长时间的坐姿劳动。当一个人坐在工位上连续工作 4 小时时，他的肛垫不再是单纯的“密封圈”，而成了支撑体重的“坐垫”。

这种功能异化导致肛垫的结构性损伤。长期受压、充血、水肿，使肛垫失去原有的弹性和支撑力，变得松弛、肥大，甚至脱出。换言之，当代青年的肛垫，不是在“工作”中受损，而是在“为工作服务”中牺牲。

5.3 痔病的“民主化”悖论

痔病的年轻化，某种程度上也是一种“民主化”。在过去，痔病被视为中老年人的疾病、男性的疾病、特定职业的疾病。但现在，痔病正在成为全民性的健康问题——不分性别、不分年龄、不分职业。

北京大学的研究显示，女性 30-39 岁组检出率高达 63.5%[2]。这一数据意味着，在 30 多岁的职场女性中，痔病已经成为常态而非例外。《中国城市居民常见肛肠疾病流行病学调查》显示，我国城市居民肛肠疾病患病率为 51.14%，痔病患病率为 50.28%[1]。这意味着，每两个成年人中，就有一个是“有痔之士”。

然而，这种“民主化”并非健康的进步，而是生活方式的集体病变。当痔病的患病率高到一定程度时，它不再是“疾病”，而成了“正常”。这种“正常化”恰恰是最危险的——当所有人都“有痔”时，便没有人觉得自己需要改变。

5.4 难以启齿的话语困境

痔病的另一个特殊性在于其话语困境。与高血压、糖尿病等慢性病不同，痔病涉及身体的隐秘部位、涉及排泄这一禁忌话题，因此成为“难以启齿”的疾病。

这种话语困境产生了一系列后果。第一，延误就医。许多患者因为羞耻而拖延，等到就医时已经发展到需要手术的程度。第二，健康教育困难。当“痔疮”这个词本身就让人尴尬时，预防知识的传播就会受阻。第三，患者互助缺失。与癌症患者可以抱团取暖不同，痔病患者往往独自承受，缺乏社会支持。

湖南省中西医结合医院肛肠二科赵亮主任

医师的提醒值得深思：青少年肛肠疾病进展速度是成人的 2 倍，早期干预可避免手术[10]。但如果青少年连开口求助都做不到，早期干预从何谈起？

6. 结论与建议

6.1 研究结论

“为什么当代年轻人频发痔疮？”——本文的分析表明，这一问题的答案远比“多吃蔬菜、少久坐”的表面建议复杂。

第一，痔病的年轻化有坚实的流行病学证据。我国城市居民肛肠疾病患病率为 51.14%，痔病患病率为 50.28%[1]。女性痔标化检出率为 43.7%，男性为 17.7%，30-39 岁女性高达 63.5%[2]。“十女十痔”不再是夸张，而是统计学真实。

第二，痔病发病机制可归纳为“四重奏”：久坐经济导致肛管持续受压[7]；排便异化使肛垫长期充血[3]；饮食异化带来辣椒素与纤维匮乏的双重打击[7]；时间贫困引发肠道节律紊乱与括约肌功能下降[7]。

第三，痔病的发生具有社会结构性根源。在“久坐经济”的劳动形态下，在“时间贫困”的生活约束下，在“数字异化”的行为模式下，痔病流行是必然的代价。个体的肛垫健康与职业要求、生活习惯之间形成根本性冲突。

第四，痔病作为一种“难以启齿”的隐疾，其社会心理影响不容忽视。羞耻感导致延误就医，话语困境阻碍健康教育，患者孤立无援。当痔病成为“难以启齿”的疾病时，它就不仅是生理问题，更是心理问题、社会问题。

第五，也是最根本的问题：当痔病的患病率高到 50%以上时，它还是“疾病”吗？还是已经成为当代生活的“标配”？这种“正常化”恰恰是最大的危险——当所有人都“有痔”时，便没有人觉得自己需要改变。

6.2 理论贡献

本研究的理论贡献主要体现在以下三个方面：

第一，整合了流行病学、病理生理学与劳动社会学视角，为理解痔病年轻化现象提供了一个多维度的分析框架。

第二，提出了“久坐经济”“排便异化”“肛垫劳损”等概念，将个体健康问题置于社会结构性变迁的背景中，揭示了痔病流行的深层根源。

第三，揭示了痔病的话语困境及其社会心理后果，拓展了对疾病社会意义的理解。

6.3 实践建议

基于上述发现，本文提出以下建议：

对个体层面：

第一，正视肛肠健康。破除“难以启齿”的心理障碍，将肛肠健康纳入日常健康管理范畴。出现便血、疼痛、脱出等症状时，及时就医而非拖延。

第二，掌握“提肛+坐浴”组合拳。每日进行提肛运动，增强括约肌弹性[7]；有条件者进行温水坐浴，促进局部血液循环[8][9]。

第三，优化排便习惯。将排便时间控制在 5 分钟以内，拒绝“带薪拉屎”的诱惑。晨起空腹饮温开水 300ml，建立条件反射。

第四，调整饮食结构。遵循“三三制”：三日放纵后需三天清淡饮食平衡，增加膳食纤维至每日 30 克。减少外卖依赖，增加蔬果粗粮摄入。

第五，建立“肛门休整期”。每坐 45 分钟起身活动 5 分钟，避免肛管持续受压[7]。利用碎片时间进行提肛运动，见缝插针地保护肛垫。

对社会层面：

第一，重构劳动伦理。在“久坐经济”的背景下，需要重新定义“敬业”的内涵。连续工作 4 小时不起身，不是敬业而是伤身；带病坚持上班，不是奉献而是愚昧。用人单位应将员工肛肠健康纳入职业健康管理范畴。

第二，推动职场健康设施建设。为久坐职业提供符合人体工学的座椅，设置站立办公区，倡导工间操文化。将温水坐浴设施纳入员工健康福

利体系。

第三，开展“去羞耻化”健康教育。通过科普宣传、公益广告、网络传播，将痔病“去神秘化”“去羞耻化”。让“痔疮”成为一个可以公开讨论的话题，让“有痔青年”不再羞于启齿。

第四，加强青少年肛肠健康教育。从学校阶段开始，教育学生养成良好的排便习惯，避免“蹲厕刷手机”的坏习惯。将提肛运动纳入体育课程，让肛肠健康意识从小建立。

6.4 研究局限与未来方向

本研究存在以下局限：第一，部分流行病学数据来自体检人群，外推到一般人群时需谨慎；第二，对“排便时间过长”的量化研究不足，缺乏大样本的行为测量数据；第三，对痔病患者的心理体验挖掘不够深入，有待质性研究的补充。

未来研究可以从以下方向深化：第一，开展大规模的行为流行病学调查，量化排便时间、久坐时长与痔病发病的关系；第二，深入探究痔病患者的疾病叙事与心理体验；第三，开展干预研究，评估提肛运动、温水坐浴等预防措施的真实效果；第四，比较不同职业、不同阶层人群的痔病患病差异，揭示痔病的社会分层特征。

6.5 结语

28 岁小伙在办公室留下一滩血，这个极具画面感的场景，是当代青年身体对“久坐经济”的极端抗议。当痔病成为 50%成年人的“标配”，当 30 岁女性患病率高达 63.5%，我们必须承认：痔病年轻化不是个体健康问题，而是时代病、职业病、生活方式病。

破解“有痔青年”困境，需要个体层面的行为改变，更需要社会层面的结构反思。我们需要追问：为什么当代青年的生活必然走向“久坐+外卖+熬夜+手机如厕”的恶性循环？当我们在 KPI 的追逐中忘记起身活动，在时间贫困中放弃运动锻炼，在数字沉迷中拉长排便时间，我们的肛垫正在默默承受一切。

湖南省中西医结合医院肛肠二科赵亮主任医师的提醒值得深思：青少年肛肠疾病进展速度是成人的 2 倍，早期干预可避免手术[10]。但比“早期干预”更根本的，是让肛肠健康成为可谈论的话题，让提肛运动成为日常习惯，让“每 45 分钟起身活动”成为职场文化。

《中国痔病患者自我管理指南》的编写者任东林等（2024）指出，痔病虽为良性病变，但其反复发作严重影响患者日常生活和工作[5]。这种影响，不仅仅是身体上的疼痛与不便，更是心理上的羞耻与孤独，是劳动中的隐忍与牺牲。

或许，真正需要的不是更多的痔疮膏、痔疮栓，而是一场关于身体与劳动、健康与生活的深度反思。在久坐经济的夹缝中，在时间贫困的约束下，在数字异化的渗透中，如何重建人与肛垫的和谐关系，如何让“有痔青年”从“难言之隐”走向“可言之痛”，是我们这个时代必须回答的问题。

参考文献（References）

[1] 江维, 张虹玺, 隋楠, 等. 中国城市居民常见肛肠疾病流行病学调查[J]. 中国公共卫生, 2016, 32(10): 1293-1296.

[2] 郭呈华, 车晓玉, 林芝, 等. 中国某健康体检人群痔的流行病学特征[J]. 北京大学学报（医学版）, 2024, 56(5): 815-819.

[3] 潮新闻. 上着班，28 岁小伙的座椅上流了一滩血！竟是这里“爆”了，年轻人中越来越常见！[EB/OL]. (2025-09-02).

[4] 田振国, 陈平. 中国成人常见肛肠疾病流行病学调查[M]. 武汉: 武汉大学出版社, 2015: 33-61.

[5] 任东林, 曾宪东, 马辉, 等. 中国痔病患者自我管理指南[J]. 结直肠肛门外科, 2024, 30(2): 129-141.

[6] Goligher J C, Duthie H L, Nixon H H. Surgery of the Anus, Rectum and Colon[M]. 5th ed. London: Baillière Tindall, 1984.

[7] 科普中国. 高考后放飞自我？当心肛肠“抗议”！这份科学放松指南请收好[EB/OL]. (2025-06-25).

[8] 湖南省中西医结合医院肛肠科. 祛毒汤熏洗治疗早期痔疮水肿的临床观察[J]. 湖南中医杂志, 2023, 39(5): 12-15.

[9] 中华医学会外科学分会结直肠肛门外科学组. 痔病诊疗指南（2020 年版）[J]. 中华胃肠外科杂志, 2020, 23(1): 1-6.

[10] 红网. 为什么痔疮发病越来越年轻化？可能和这些因素有关[EB/OL]. (2023-03-22).